

想定	令和8年9月某日 天候晴れ 気温15度								
	全体	本部	現場司令班	救急外来	軽症/トリアージ	召集される人員 (医師・看護師・搬送)	手術室	ICU	一般病棟(連結なし)
～9:15	9:00に開会式を終了し配置につく	本部統括司令部はF棟CS前の廊下スペースで待機	ER日勤想定メンバー（後の 現場司令Dr.Ns/救外リーダー-Dr/各ゾーンのNsリーダー）はERで待機						
9:15	【防災】防災センターより全館放送「訓練、地震発生」その後Dモード発令「Dモード」	防災センターより地震の放送、Dモード発令 アクションカードに従い被災状況を確認し現況報告（緊急入力）を開始				応援要員はKビルで待機し、本部やERの動きをライブ動画でみてもらう	Dモード アクションカードに基づいて各手術室のチェック 現状報告	Dモード アクションカードに従い状況を把握 現状報告	Dモード アクションカードに従い状況を把握 現状報告
9:15-20	本部立ち上げ	統括指令班員は(仮想)防災センター（F棟1階廊下）へ集合。集約した情報(現状報告①)を確認、院内被災あり、また多数傷病者も予測し、本部立ち上げを決定。 本部立ち上げの放送 その後他の本部要員とともにF棟1階災害対策室へ移動。	ERで患者を診療中 めまい（Fベッド）、失神（ER1）の2名の患者				現況報告終了後、第一次非常配備が放送される前に、手術室の意見をまとめておく 想定回答「3室退室、3室退室準備」	現況報告終了後、第一次非常配備が放送される前に、ICUの意見をまとめておく	各病棟から本部へ報告 ※実際の病棟訓練とは切り離し
9:20-25		チームビルディングしアクションカード配布							
9:25	小樽消防からERに、多数衝突事故発生の連絡	ERから、多数衝突事故発生と、現場指令班立ち上げ・受け入れ準備開始したいという連絡あり。	小樽消防より多重衝突事故の連絡「小樽市張碓付近の国道5号線でマイクロバスを含む多重衝突事故発生、傷病者多数いる模様」 多数傷病者発生を予測し、受け入れ体制を整える必要があると判断。 本部へ現場指令班立ち上げ・受け入れ準備開始したいという要望を連絡 2名の救急患者の転搬を決定（いずれも押毛可能、人形なし）						
9:35	第一非常配備	現況報告①も併せて「院内一部被災あるが診療継続可能 多数傷病者の受け入れ必要」として 第一非常配備を放送 ・ERへは現場司令部を立ち上げるように指示。 ・手術室から被災状況の報告あり。定期手術中止について判断。 ・応援人員を招集（DR、NS、リハICTEL） （C：ERに派遣できる医師、看護師・事務員のリストを診療指令班に提出） ・A西7,SCU：水道使用不可の対応を検討（上下、同じフロアの水道を使用、もしくは転機） ・A東7：PC故障の対応を検討	本部から現場指令班の立ち上げを依頼され、第一非常配備の受け入れ準備を開始する				第一非常配備 手術室統括は本部（診療司令部）と連携し、手術継続・中止の判断を行う。	第一非常配備 今後の入室数の増大を予測し、ベッドコントロールを話し合う	
9:36-40	(支援メンバー移動)		※支援メンバーは、Kビルから各ゾーンへ移動					本部に調整後の受け入れ可能人数（●名）を報告	
9:40	支援メンバーがERに到着しチームビルディング開始	本部活動 ・現状分析と課題 ・ICUの運用方針を決定、すでに入室している患者の一般床への退室が必要と判断し、ICUに空床を作るように指示 ・オベ室に受け入れ可能人数を確認 ・HOT患者の対応を検討	ERへ他科の医師・看護師・事務員・搬送班が集合。（ゾーンリーダーのみ、Dr1、Ns1） リーダー以外は、Kビルから直接、各ゾーンへ チームビルディングを行い、アクションカード配布、受け入れ準備を開始。					本部から空床をつくるよう調整の指示があり、一般床への転機を調整開始する ※本部に一般床のベッド状況などの情報を確認する	
9:45	小樽消防局より多重衝突事故の連絡	現場指令班から、小樽消防からの情報が報告され、受け入れ人数を検討。→全広域の方針 事故現場へのDMAT派遣を検討	ホットラインは救外ゾーンで担当 ・小樽消防局からの受入態勢確認の連絡：「地震および多重衝突事故での被災者受入態勢を、トリアージ区分ごとに教えてほしい。現場は混乱。現在救助活動中、多数傷病者あり。救急隊によるトリアージで、すでに赤6名、黄10名程度確認。搬送準備が整い次第、搬送開始したい。」 救外→現場司令→本部に報告。小樽消防には本部と相談した結果の受け入れ人数を伝える。					患者を転機させる（机上演習）	訓練終了
10:05	最初の患者が来院		以降、以下業務を行う ・ICU、EUへの入院調整 ・各ゾーンの状況把握、ニーズ把握、アセスメント ・本部への連絡、提示報告	救急車① 症例No.1 来院（ICU症例）				本部に現在の空床数●床と報告	
10:08				乗用車① 症例No.2 来院（ICU→手術症例）	乗用車①が到着 症例No.5(トリアージアプ、手術)が軽症ゾーンへ				
10:14				救急車② 症例No.3 来院（手術、ICU症例）					
10:23				救急車③ 症例No.13 来院（ICU→手術症例）					
10:30				ICUへ 症例No.1 の入室依頼（見込み）					
10:35				手術室へ 症例No.3 のICU室依頼（見込み）					
10:42				救急車⑤ 症例No.35 来院（ICU症例）	乗用車⑥ 症例No.36 来院				
10:45	転院必要な症例への対応	現場司令から本部に転院調整依頼 転院症例は搬送手段と搬送先を調整 （C：市立札幌病院が1名受け入れ可能であることを情報司令部に伝える。消防の救急車は対応困難、本部プレーヤーから病院救命士に搬送依頼の電話をかけてもらう）	転院調整を本部に依頼 症例No.13（見込み）						
10:50	余震(震度6弱)発生、防災センターから放送 北電からの電気供給が停止、自家発電が稼働	防災センターより地震放送 C：地震が発生しています。一度手を止め安全確保を行ってください。（部屋の電気を一度消灯） 1分後から訓練再開							
10:51	訓練再開			救急車⑥ 症例No.40 来院（ICU→手術症例）					
10:55		改めて情報収集を行う（放送使用可）現状報告② 北電からの電気供給が停止し、自家発電が稼働中、G棟停電 ・本部は燃料調整、今後の方針決定、節電対策を検討(館内放送使用時は防災センター経由) →現場司令部や手術室、ICUにも情報を共有	各ゾーンから情報収集し、本部に現状報告を再度行う 本部から自家発電稼働中、節電の指示	現場司令部に現状報告を行う	現場司令部に現状報告を行う 乗用車⑥ 症例No.41 来院（ICU症例）		本部に現状報告を再度行う 本部から自家発電稼働中、節電の指示	本部に現状報告を再度行う 本部から自家発電稼働中、節電の指示	

11:00		オベ堂からエレベーター(ABF棟)停止の報告、対策検討					本部に「ABF棟のエレベーターが停止しており、患者退出ルートをどうしよういのか相談したい」と連絡		
11:01				救急車㉗ 症例No.46 来院 (ICU症例)					
11:10				救急車㉘ 症例No.47 来院 (ICU症例)					
11:20					症例No.49 来院 ※最後のwalkin症例				
11:30				救急車㉙ 症例No.50 来院 (手術症例) ※最後の救急車					
11:55	訓練終了(放送)								